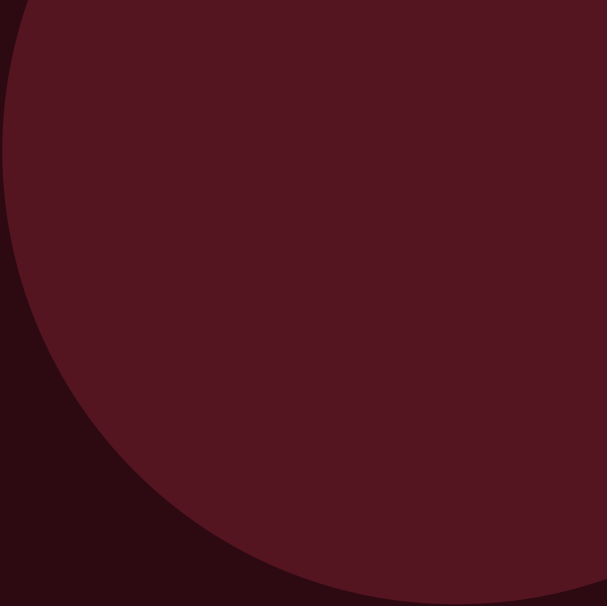




DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 05 DE 12

Aceitação, mudança e dialética

A aceitação não é um módulo a mais. É a postura que sustenta todos os outros, e sem ela a estratégia de mudança chega ao paciente como mais uma voz dizendo que ele está errado.

ENCONTRO DE SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2026 · 10H ÀS 12H
CONDUZIDO POR JÚLIO GONÇALVES

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

- **Aceitação vem antes da mudança e atravessa todos os módulos.** Protocolo aplicado sobre relação frágil produz efeito iatrogênico.
- **Resignação desiste; aceitação mantém a porta aberta.** Validar serve para instilar esperança, não para acomodar o sofrimento.
- **O terapeuta invalida sem perceber.** Moralizar, advertir, ironizar, analisar na hora errada e usar "mas" estão na lista.
- **Valida-se o sofrimento e a função, nunca o comportamento de risco.** A vontade de anestesiá-la dor é legítima. O comportamento que anestesia segue como alvo.

01 Por que a postura vem antes da técnica

A prática clínica costuma correr para avaliações extensas e intervenções imediatas. Essa pressa gera postura iatrogênica e invalidante. A DBT pede o contrário: postura ancorada no modelo biossocial, com aceitação antes da mudança.

O erro mais comum é negligenciar a relação terapêutica em nome do protocolo. A aceitação é base transversal de todos os módulos do tratamento, não um módulo a mais.

02 Aceitação e resignação

As duas cessam a briga aberta com o fato. O que acontece depois é diferente.

RESIGNAÇÃO

Desistência. O fato é tomado como imutável e a pessoa para de agir.

Segue julgando a realidade como errada.

Fecha o campo de ação.

Passividade diante do sofrimento.

ACEITAÇÃO

Reconhece o fato e mantém abertura para a mudança possível.

Respeita o contexto e as habilidades atuais.

Abre o campo de ação.

Validação que instila esperança.

O teste não está no que a pessoa sente. Está no que ela consegue fazer em seguida.

A ferramenta para sair da resignação são os dilemas dialéticos: nomear os dois polos e apostar em mudanças pequenas.

03 Escutar sem prejudgamento

A aceitação começa como um jeito de escutar, e isso se decompõe em três coisas observáveis: cordialidade, na postura corporal e no ritmo de fala; comunicação, na quebra de formalidades desnecessárias; e consideração positiva incondicional.

O terceiro item é o mais difícil, e a aula não fugiu do caso limite: como emitir consideração positiva diante de quem cometeu violência grave. O argumento discutido foi que o sofrimento humano não é escolha consciente, e sim resultado de desregulação complexa. Isso não absolve o comportamento. Sustenta a possibilidade de trabalhar com a pessoa.

04 Como o terapeuta invalida sem perceber

MODOS FREQUENTES DE INVALIDAÇÃO

Argumentação	Moralização	Desaprovação	Estigma do diagnóstico
Advertência de cima	Ironia	Análise na hora errada	A conjunção "mas"

A troca que a simulação mostrou
"Entendo que foi difícil, mas você precisava ter feito a tarefa."
"Entendo que foi difícil, e a gente precisa achar um jeito de a tarefa caber na sua semana."

O "mas" apaga o que veio antes. O "e" preserva a validação e mantém o pedido de mudança.

Falas afirmativas que julgam ou culpabilizam por faltas e falhas travam o avanço. O caminho é a pergunta aberta, que estimula curiosidade e autonomia e revela as contingências reais por trás do comportamento.

05 Estilo do terapeuta e prognóstico

Dois estilos foram contrastados. O afetuoso, receptivo e democrático trabalha por perguntas e devolve autonomia, com prognóstico favorável. O diretivo, moralista e frio trabalha por cobrança, com prognóstico pessimista.

Um detalhe contraintuitivo

Pacientes controladores costumam procurar terapeutas diretivos. O arranjo é confortável para os dois e mantém tudo como está. O estilo democrático incomoda mais no começo e é o que produz autonomia.

06 Reatância: o conselho que produz o oposto

Conselho diretivo, dado sem investigar a função do comportamento e sem validação prévia, ameaça a autonomia e ativa o modo opositor. Isso pesa mais em quem tem histórico de humilhação e invalidação.

O exemplo trabalhado foi o consumo de álcool. Antes de propor conduta, pergunte para que aquilo serve. Depois peça permissão e apresente a proposta em aberto.

07 Os seis níveis de validação

A base é o silêncio atento e a escuta sem interrupção. Relatos que parecem neutros carregam sofrimento implícito, e ele só aparece se houver espaço.

A vinheta usada em aula foi a de uma paciente falando de um e-mail que o chefe não respondeu. O trabalho ali foi a descrição objetiva do que aconteceu e a autorrevelação genuína do terapeuta, ligando a história pessoal dela ao sofrimento atual.

NOMEAR A EMOÇÃO PELO PACIENTE

Surgiu a dúvida sobre atribuir emoções que o paciente não explicitou. O caminho é abrir espaço para ele descrever as próprias sensações. Recorrer à formulação prévia só quando o repertório estiver limitado por desregulação forte ou dissociação.

08 O que se valida e o que não se valida

O erro é validar o comportamento nocivo em si. Beber para atravessar um término é o exemplo. O desejo de anestesiarmos a dor é legítimo e merece validação. O comportamento que anestesia continua sendo alvo de análise.

Valide o sofrimento e a busca por apoio. Questionar a eficácia do comportamento destrutivo sem dar aval a ele.

09 Os cinco princípios da postura

Consciência do momento presente

Atenção plena a cada palavra. O risco é o terapeuta apressar o alívio movido pela própria angústia.

Impermanência

Emoção e contexto mudam sozinhos. Reconstruir a crise hora a hora mostra ao paciente que o pico passou.

Interexistência

Comportamento do paciente e reação do terapeuta estão sob contingências mútuas. Atraso vira dado, não ofensa.

Desapego

Apego é exigir que a realidade fosse outra. Alimenta ruminação, cansaço e comportamento desadaptado.

O mundo é perfeito como ele é

Perfeito no sentido de completo. Os eventos ocorreram pela convergência das variáveis daquele contexto.

Os cinco princípios organizam a postura de aceitação. Valem para o paciente e para o terapeuta.

Momento presente. Pacientes choram e se desregulam na sessão, e o terapeuta tende a intervir rápido por causa da própria dor de assistir. Suportar um minuto de sofrimento em ambiente controlado constrói tolerância emocional. O papel é validar sem resgatar cedo demais. Há dois desvios a evitar: ser puxado para o passado do paciente e oferecer solução antes de avaliar as habilidades que ele já tem. A saída é voltar ao aqui e agora com perguntas sobre a relação terapêutica.

Desapego. Brigar com fato passado prolonga o sofrimento. A prática envolve adiar a ruminação e adotar ação oposta, em vez de entrar na discussão ou tentar consertar na hora.

Interexistência. Ela inclui a biofisiologia do terapeuta. Cansaço, noite mal dormida e estresse produzem impaciência e invalidação sutil. Daí a importância do grupo de consultoria, do autocuidado e de uma agenda viável.

Impermanência. O medo de que a melhora seja seguida de dor leva à resignação. Tratar os altos e baixos como lombada evita que se construam barreiras rígidas de evitação.

A ansiedade do terapeuta

A pressão por mudança rápida costuma vir do medo de ser julgado ou abandonado pelo paciente. Agir como bombeiro é apego a norma social, não foco no sofrimento real. Explicação em excesso funciona como ruminação ativa.

10 Aceitação radical: habilidades e equívocos

Foram apresentadas seis habilidades centrais de aceitação, entre elas a aceitação radical, o redirecionamento baseado em mindfulness, o meio sorriso e a postura corporal. A justificativa para as duas últimas vem de estudos sobre como a postura física modula a resposta fisiológica.

O módulo se divide em duas frentes. Sobrevivência à crise reúne distração e autorregulação. Aceitação da realidade trata de situações que não vão mudar.

DOIS EQUÍVOCOS A EVITAR

O primeiro é confundir aceitação radical com aprovar comportamento de risco. Valida-se o contexto, a emoção e o sofrimento que impulsionam o ato, nunca o ato. O segundo é usar aceitação como autoindulgência para procrastinar ou como passividade diante da mudança.

Também foi separada a leitura espiritual ou moral de eventos traumáticos da análise por contingências. A aceitação radical reconhece que a negligência não deveria ter acontecido do ponto de vista moral, e que, dadas as condições daquele ambiente, aconteceu. O trabalho parte da realidade presente.

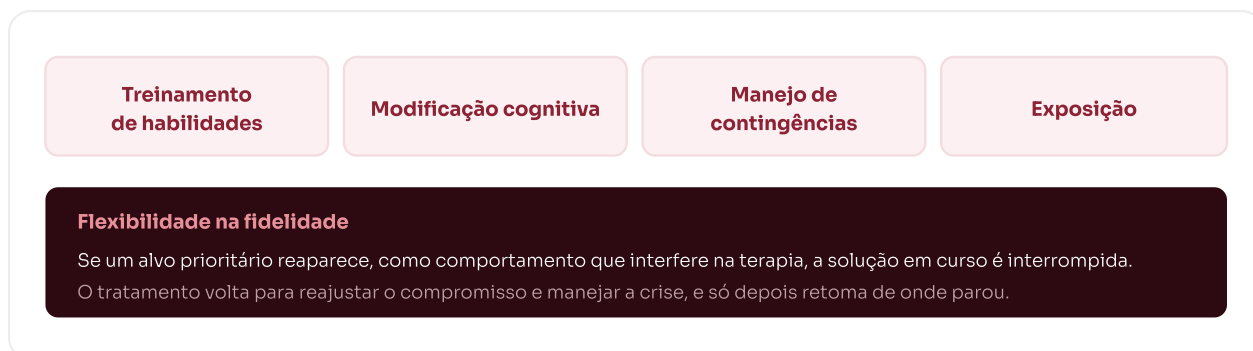
11 Da hierarquia de alvos à análise em cadeia

A ordem de prioridade se mantém: comportamentos que ameaçam a vida, os que interferem na terapia, os que afetam a qualidade de vida e, por fim, o aumento de habilidades.

A análise em cadeia é o que identifica a função de cada comportamento. Baixar emoção, evitar exigência, buscar atenção. Topografias idênticas podem ter funções distintas, e é a função que orienta a intervenção.

Depois de mapear o padrão, escolha o elo mais acessível e mais tolerável para intervir. O ambiente de suporte precisa ser avaliado com cautela, para não reforçar o sofrimento. A partir daí se constroem plano de segurança e ensaios comportamentais de curto prazo.

12 As quatro categorias operacionais



As quatro categorias de intervenção e a regra que permite sair do roteiro sem sair do modelo.

13 Treinar a postura com simulação

A sugestão feita em aula foi usar inteligência artificial para simular atendimentos e estudos de caso focados nos princípios da DBT. O ganho relatado é treinar validação e perceber a própria tendência a explicar demais ou a conduzir demais.

14 Levar para a prática

16 Referências

- Swenson, C. R. (2016). *DBT principles in action: Acceptance, change, and dialectics*. Guilford Press.
Edição brasileira: *Terapia comportamental dialética em ação*. — princípios da postura de aceitação.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
— validação, estratégias de aceitação e hierarquia de alvos.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2ª ed.). Guilford Press. — aceitação radical, meio sorriso e tolerância ao mal-estar.

NOTA DE MÉTODO

Resumo escrito a partir das anotações do encontro. Participantes não são identificados e a vinheta clínica usada em sala aparece sem nome. O sobrenome do autor citado para a definição de aceitação em três partes e para os cinco princípios aparece distorcido na transcrição automática; atribuí a Charles Swenson, que é a fonte desses princípios nas aulas anteriores, e deixo a correção registrada para conferência no slide. Os estudos sobre postura corporal e resposta fisiológica foram mencionados sem referência e por isso não entram na lista acima. Os diagramas desta página foram desenhados a partir do conteúdo da aula.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- ☐ contei quantas vezes usei "mas" depois de uma validação, numa sessão, e troquei por "e".
- ☐ Segurei um minuto de silêncio diante do choro do paciente, sem resgatar cedo demais.
- ☐ Antes de sugerir conduta, investiguei a função do comportamento e pedi permissão.
- ☐ Reconstruí com o paciente o histórico de uma crise, hora a hora, para mostrar a impermanência.
- ☐ Identifiquei em qual princípio da postura eu escorrego mais, e o que o cansaço faz com a sessão.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Um paciente conta que bebeu por três dias seguidos depois do término. O que você valida e o que você não valida?

02. Qual a diferença prática entre aceitação e resignação na condução de uma sessão?

03. Cite três modos de invalidação que você reconhece na sua própria prática. Em que situação cada um aparece?

04. O paciente chora e você sente vontade de intervir. O que o princípio da consciência do momento presente orienta fazer?